



Análisis de Estratificación de Riesgo Cardiovascular (CV)

50

Total Pacientes

Riesgo CV

- ☐ Alto
- ☐ Bajo
- ☐ Medio

Alteracion ECG

- ☐ No
- ☐ Si

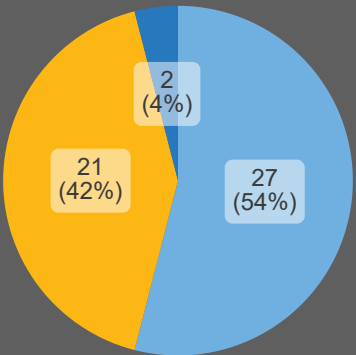
Sexo

- ☐ F
- ☐ M

HTA

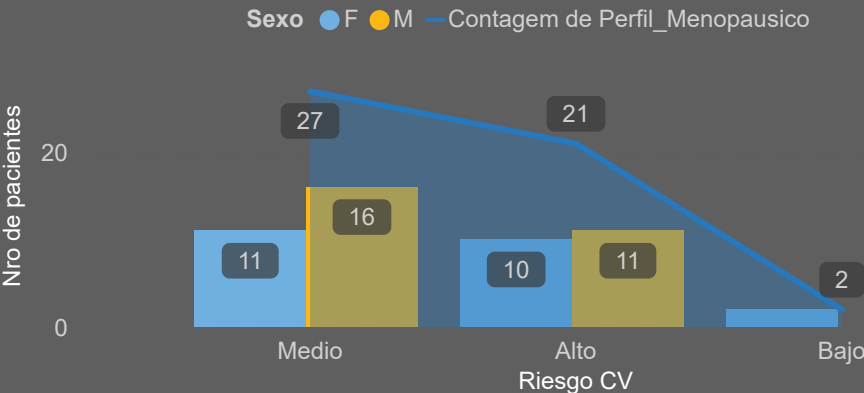
- ☐ HTA
- ☐ Limitrofe
- ☐ Normotension

Perfil de Colesterol LDL

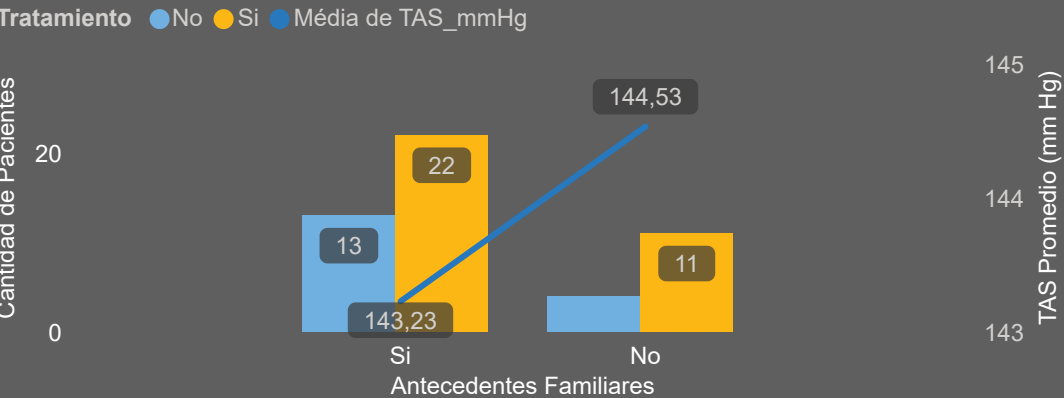


Objetivo_... 100 70 130

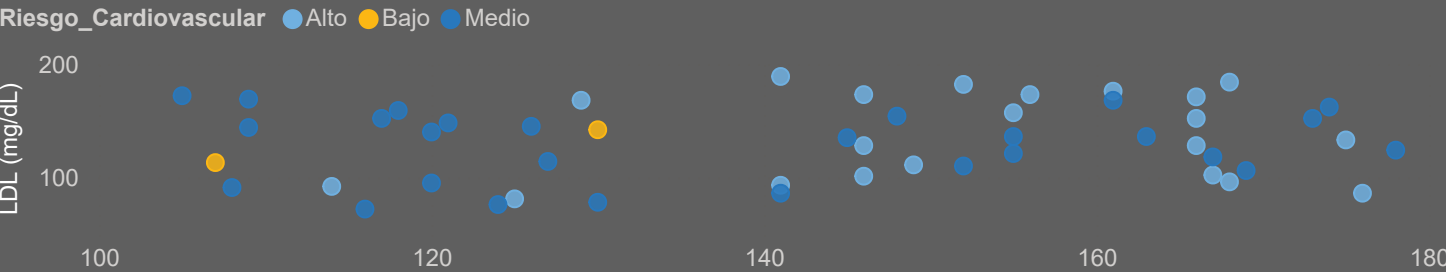
Distribución de Riesgo por Sexo y Impacto del Perfil Menopáusico



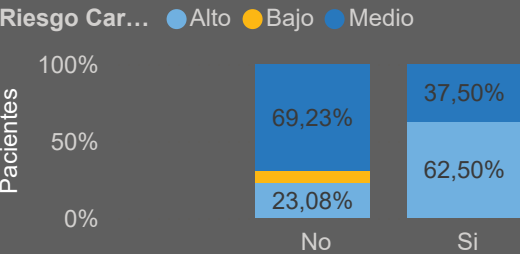
Presión Arterial Promedio según Tratamiento



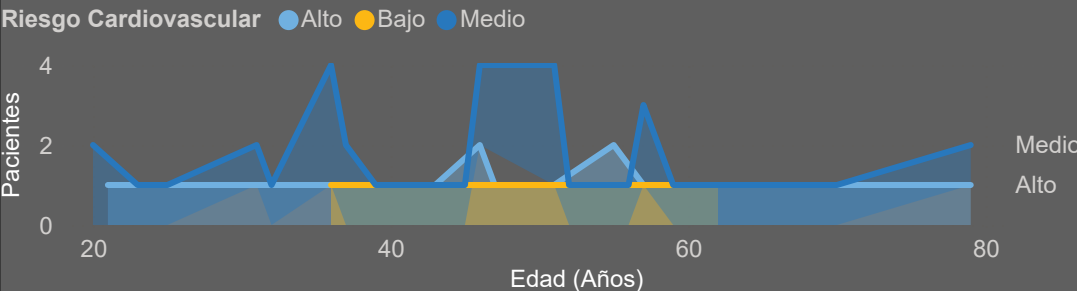
Análisis de Dispersión: Presión Sistólica (mmHg) vs. Colesterol LDL



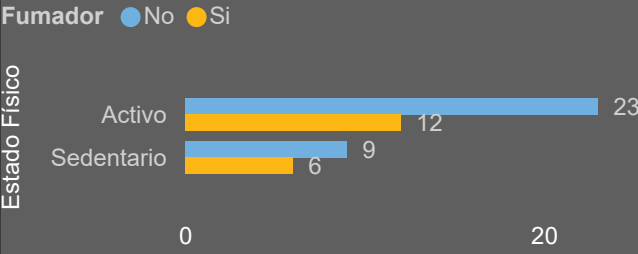
Impacto de la Carga Hereditaria en el Riesgo CV



Riesgo Cardiovascular según la Edad



Distribución de Factores de Riesgo Modificables



1.Distribución por Sexo y Salud Femenina

Introducción al Análisis Clínico

Este informe consolida la evaluación epidemiológica de una cohorte de **50 pacientes** en prevención primaria dentro del CAPS.

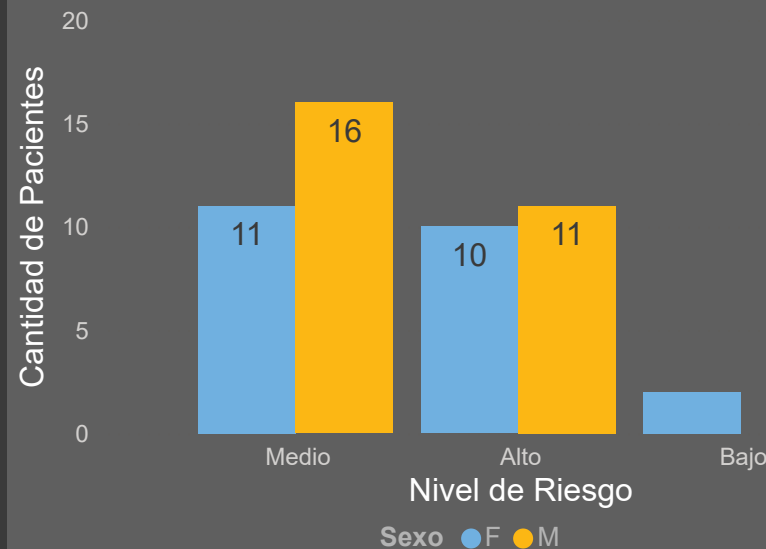
Al analizar la población, se segmentó el impacto por sexo biológico e impacto hormonal específico en las **mujeres**. Los datos evidencian que, en la población **femenina**, la transición hacia la **ostmenopausia** actúa como un punto crítico de vulnerabilidad, acelerando el **riesgo moderado y alto** debido a la pérdida de la protección estrogénica natural.

• **Prevalencia de Riesgo:** La categoría predominante en la cohorte es el **Riesgo Medio** (27 pacientes), seguida por un volumen crítico de **Riesgo Alto** (21 pacientes).

• Distribución por Sexo:

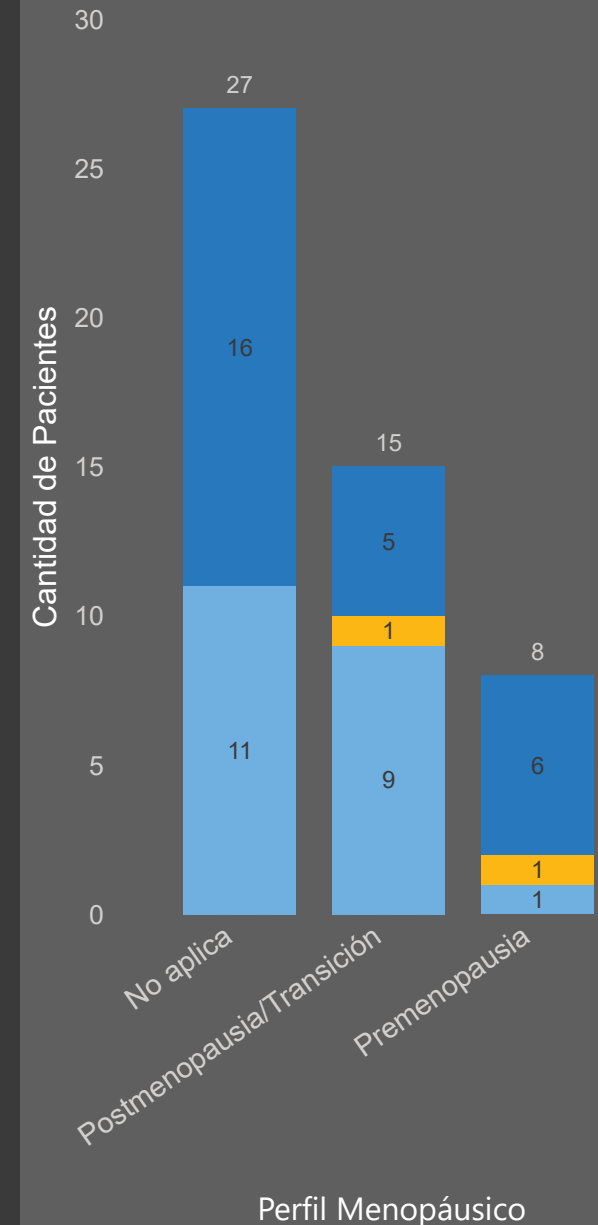
- En el **Riesgo Alto**, la distribución es equitativa (**10 Mujeres** / **11 Varones**).
- En el **Riesgo Medio**, se observa una mayor concentración de **Varones** (**16**) frente a **Mujeres** (**11**).

Distribución de Riesgo por Sexo



Impacto del Perfil Menopáusico

Riesgo_... ● Alto ● Bajo ● Medio



2.Control Hemodinámico y Metas de LDL

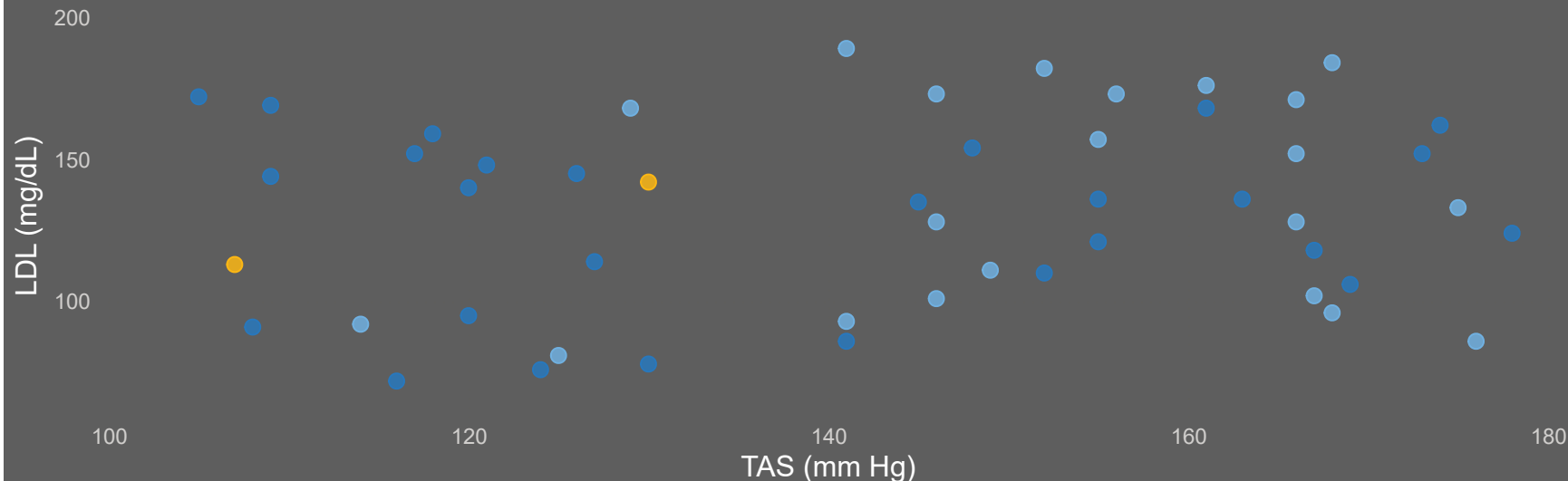
Análisis Metabólico y Objetivos Terapéutico

El análisis conjunto de las variables biomédica permite evaluar el estado hemodinámico real de la población e identificar los puntos críticos para la toma de decisiones clínicas.

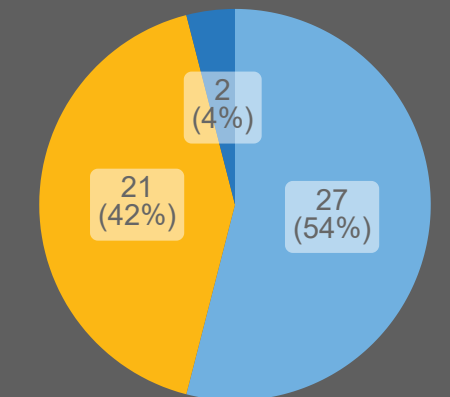
- **Estratificación por Riesgo:** El gráfico muestra que un **42% (21 pacientes)** de la población se encuentra clasificado bajo **Riesgo Alto**. Este subgrupo prioritario exige el cumplimiento mandatorio de objetivos lipídicos estrictos (**LDL < 70 mg/dL o < 55 mg/dL** según guías de consenso vigentes) para frenar la progresión de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica.
- **Comportamiento Hemodinámico (TAS vs. LDL):** Se observa una alta densidad de casos concentrados en el cuadrante de valores elevados de presión arterial sistólica combinados con dislipidemia. Esta distribución facilita la detección inmediata de **casos atípicos** fuera de rango clínico para su intervención oportuna.

Análisis de Dispersión: Presión Sistólica vs. Colesterol LDL

Riesgo_Cardiovascular ● Alto ● Bajo ● Medio



Perfil de Colesterol LDL



Objetivo_LDL ● 100 ● 70 ● 130

3.Impacto del Tratamiento y Medicación

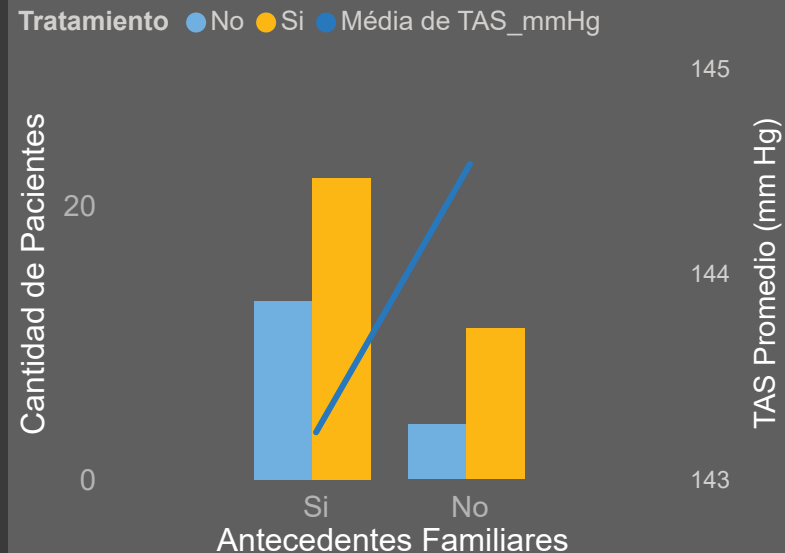
Auditoría de Tratamiento e Inercia Hemodinámica

La evaluación de la farmacoterapia activa en relación con las cifras tensionales revela ventanas críticas para la optimización del control clínico en el CAPS.

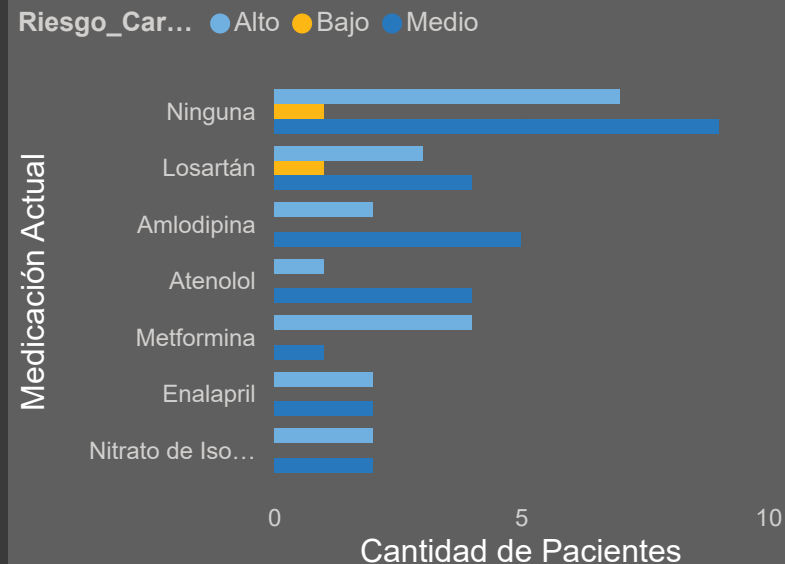
· **Ventana de Inercia Clínica:** Los pacientes bajo tratamiento activo mantienen una **media de TAS de 144,53 mmHg**. Este valor se sitúa por encima de los objetivos recomendados de control (< 140/90mmHg), evidenciando que los esquemas actuales (principalmente monoterapias) resultan insuficientes para mitigar el riesgo en presencia de antecedentes familiares.

· **Análisis de Farmacoterapia:** La distribución muestra una alta prevalencia de uso de **Losartán**, seguido por **Amlodipina** y **Atenolol**. La persistencia de valores tensionales elevados en este grupo resalta la necesidad de revisar la adherencia al tratamiento o migrar hacia esquemas de terapia combinada para alcanzar las metas de protección cardiovascular.

Presión Arterial Promedio según Tratamiento



Distribución de Farmacoterapia por Riesgo



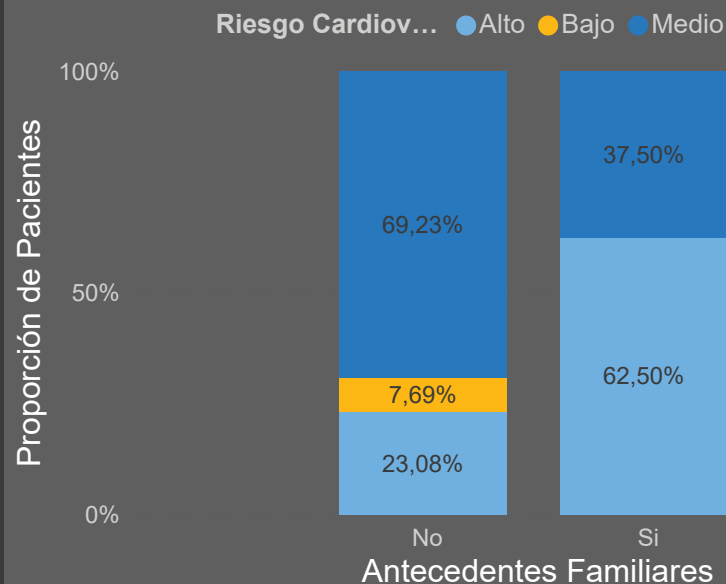
4. Análisis de Riesgo por Edad y Herencia

Evolución del Riesgo, Edad y Componente Hereditario

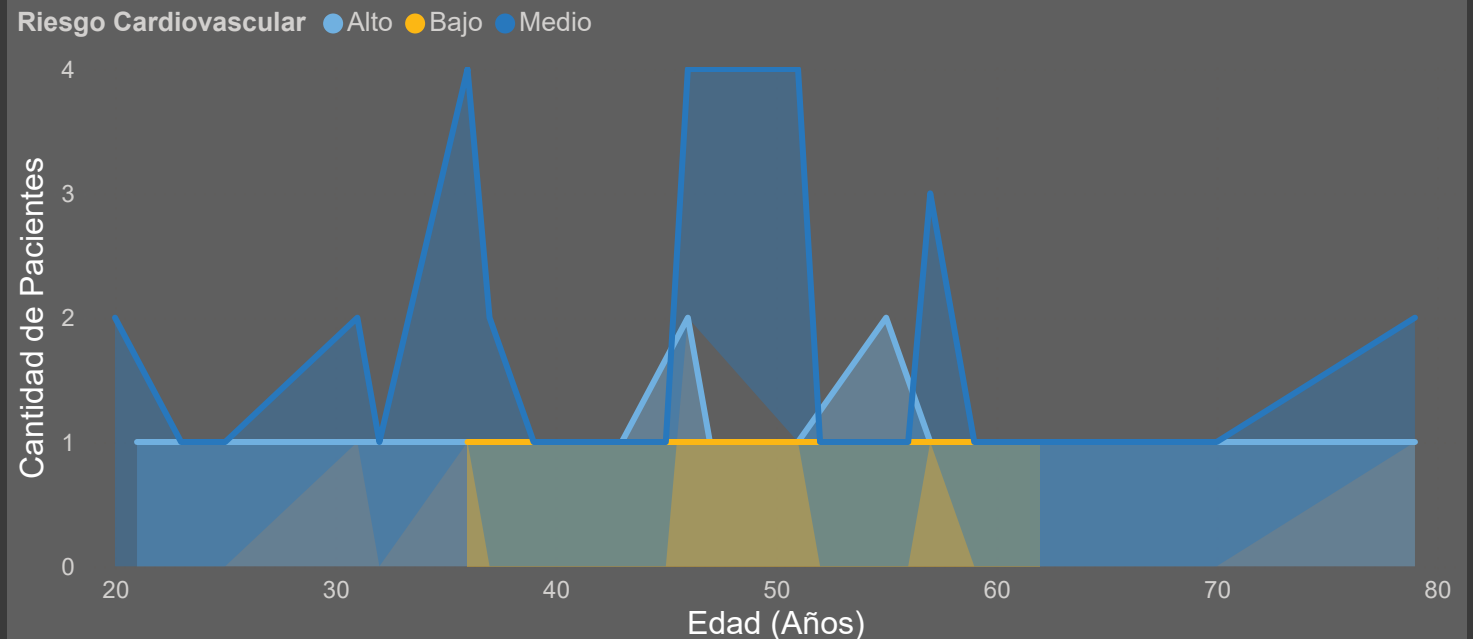
La estratificación del riesgo cardiovascular demuestra una aceleración condicionada por factores biológicos no modificables dentro de la población evaluada del CAPS.

- **Efecto de la Carga Genética:** La presencia de antecedentes familiares altera significativamente la vulnerabilidad tisular y metabólica. El subgrupo con historia familiar positiva duplica la prevalencia de categorías de **Riesgo Medio y Alto**, consolidando a la herencia como un marcador clave para el tamizaje preventivo temprano.
- **Punto de Inflexión Cronológico:** El comportamiento del riesgo alto experimenta una aceleración crítica al cruzar la barrera de los **50 años**. Este comportamiento epidemiológico marca la ventana mandatoria donde **el equipo de salud debe intensificar los controles preventivos** antes de la aparición de eventos clínicos mayores.

Impacto de la Carga Hereditaria en el Riesgo CV



Distribución Epidemiológica del Riesgo por Edad



5.Estilo de Vida y Diagnóstico Electrocardiográfico

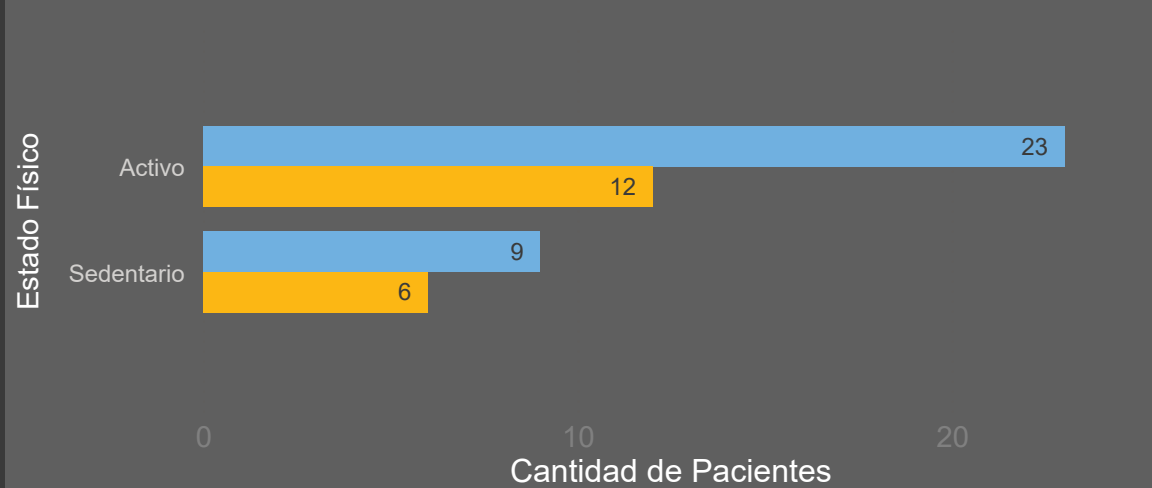
Hallazgos Electrocardiográficos y Conductas de Salud

El cruce de los hábitos de vida con el registro eléctrico permite al equipo de salud identificar el impacto real de la carga metabólica sobre la infraestructura cardíaca de la población.

- **Diagnóstico por ECG:** La elevada prevalencia de trazos patológicos (como isquemias o sobrecargas) en los estratos de riesgo medio y alto valida la necesidad de que **el equipo de salud mantenga una vigilancia activa** sobre estos pacientes. El hallazgo confirma al ECG como una herramienta mandatoria para la detección temprana de daño de órgano blanco.
- **Carga de Riesgo Conductual:** El sedentarismo y el tabaquismo representan la mayor densidad de riesgo modificable, concentrando el mayor volumen demográfico en el perfil físicamente inactivo de la cohorte.

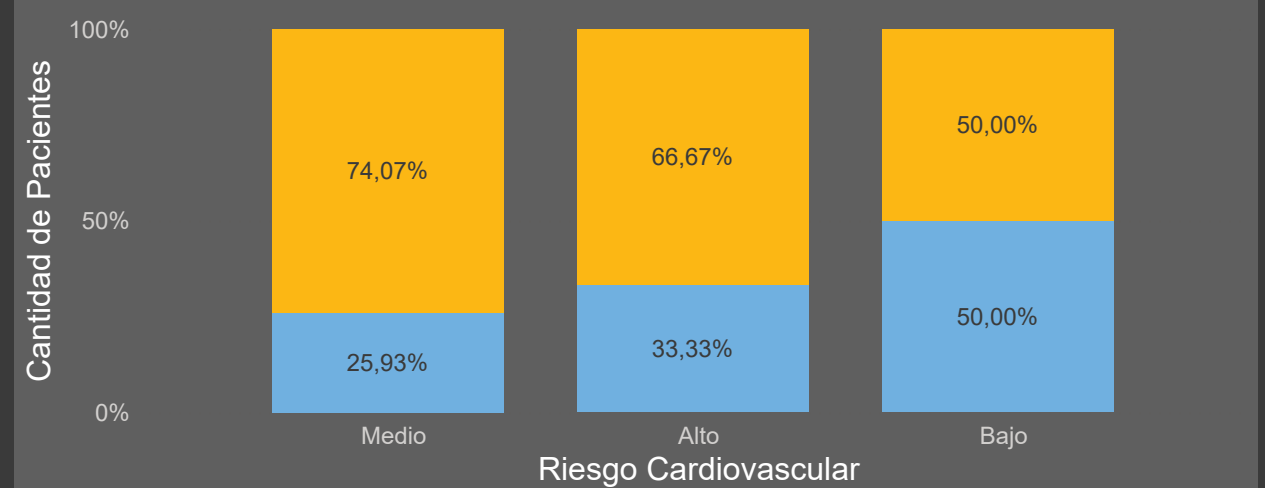
Distribución de Factores de Riesgo Modificables

Fumador ● No ● Si



Alteraciones del ECG según Nivel de Riesgo

Alteracion_ECG ● No ● Si





6. Estrategias y Líneas de Intervención de Equipo

Plan de Acción y Gestión Estratégica del Equipo de Salud

Basado en el diagnóstico de la cohorte, el equipo de salud establece las siguientes directrices para optimizar el control clínico y reducir la morbilidad cardiovascular:

· Estrategia A: Control de Pacientes Críticos (Auditoría e Intervención)

Pacientes en
Riesgo Alto

21

- **Objetivo:** Reducir la probabilidad de eventos cardiovasculares mayores (IAM/ACV) en el grupo de Riesgo Alto.
- **Acción:** Movilizar al equipo para la búsqueda activa de los **21 pacientes** de Riesgo Alto. Se priorizará el control de laboratorio (Perfil Lipídico), la optimización de la farmacoterapia ante inercia clínica y el seguimiento electrocardiográfico seriado.

· Estrategia B: Prevención Primaria Focalizada (Salud del Varón y Vida Activa)

Varones en Riesgo
Medio

16

- **Objetivo:** Evitar la progresión de Riesgo Medio a Riesgo Alto en la población masculina.
- **Acción:** Coordinar un programa de seguimiento trimestral para los **16 varones** en Riesgo Medio. El equipo se enfocará en el control estricto de la Tensión Arterial y la derivación efectiva hacia circuitos de actividad física supervisada en el CAPS.

· Estrategia C: Monitoreo Especializado (Salud de la Mujer y Postas de Salud)

Mujeres en Riesgo
Alto

10

- **Objetivo:** Evaluar y mitigar el impacto del estatus hormonal en el riesgo cardiovascular femenino.
- **Acción:** Implementar el programa "**Postas de Salud - Mujer**" para las **10 pacientes** de Riesgo Alto. El equipo de salud cruzará los datos de transición climática para determinar, junto a ginecología, la necesidad de pautas de protección vascular o terapéutica específica.